

**PERJANJIAN PENGIKATAN KERJASAMA
PELAYANAN PESERTA BPJS
Dr. H. AKHMAD TAUFIQURAHMAN, MMKes
DENGAN
LABORATORIUM MEDIS DHARMA HUSADA
No : 0064/DPP/XII/2025
No :**

Pada hari ini , Selasa, tanggal tujuh belas (17) Desember tahun dua ribu dua puluh empat (2024)

Yang bertandatangan dibawah ini :-----

1. Nama : **Dr. H. AKHMAD TAUFIQURAHMAN, MMKes.**
SIP : 446/097/425.117/SIPDU/2022-----
Pekerjaan : Praktek Mandiri Dokter -----
Alamat : Jl. Kinibalu I No.1A Perum Bromo Permai. Ketapang Kota
Probolinggo-----

selanjutnya disebut ***pihak I (pertama)***,-----

2. Nama : **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE**
Jabatan : Direktur
NPWP : 1000 0000 0251 6066
No SIOP : 446/001/425.117/RS.KELAS D/2021
No. Tlp : 0335 – 422176
Alamat : , Jl. Soekarno Hatta No 10 Kec. Mayangan Kota Probolinggo-

selanjutnya disebut ***pihak II (kedua), Direktur Laboratorium Klinik***

Dharma Husada-----

Para pihak menyatakan dengan ini telah sama setuju dan semufakat untuk membuat Surat Perjanjian Pengikatan Kerjasama dengan ketentuan dan / atau syarat - syarat sebagai berikut :-----

PASAL 1

UMUM

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai salah satu Laboratorium yang memberikan pelayanan dalam hal Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang ditulis untuk kepentingan Pelayanan Pemeriksaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA akan memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya.
3. PIHAK KEDUA menjamin atas berlakunya Surat Izin Berusaha dan perangkat terkait masih syah semasa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2

LINGKUP PALAYANAN

1. Jenis pemeriksaan yang boleh dilayanani pihak kedua adalah yang ditulis pihak pertama menggunakan blanko Laboratorium beridentitas PESERTA BPJS.
2. Pihak kedua tidak diperkenankan menarik biaya atas beban Pemeriksaan Laboratorium yg ditulis pihak pertama.

PASAL 3

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA menagihkan seluruh biaya Pemeriksaan Laboratorium yg telah dilayani kepada pihak kedua paling lambat tgl 10 pada bulan berikutnya dengan melampirkan bukti identitas pasien yg telah dilayani.
2. PIHAK PERTAMA membayar tagihan pihak kedua paling lambat 15 hari sejak tagihan disampaikan oleh pihak kedua.

PASAL 4

PEMERIKSAAN LABORATORIUM DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG KOMPETEN DAN BERPENGALAMAN UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU MENGINTERPRETASIKAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan PIHAK KEDUA
2. Tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka pelayanan
3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh analis/petugas yang terlatih dan berpengalaman
4. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang terlatih dan berpengalaman

PASAL 5

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SPESIFIK UNTUK SETIAP JENIS PEMERIKSAAN

LABORATORIUM

1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpan spesimen
2. Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium
3. Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur tersebut
4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
5. Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di luar jam kerja
6. Ada kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya spesimen sputum, darah dan lainnya)
7. Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan alat pelindung diri bagi petugas laboratorium
8. Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri dan pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja
9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah medis hasil pemeriksaan laboratorium
10. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di laboratorium
11. Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengelolaan limbah medis apakah sesuai dengan prosedur

PASAL 6

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM SELESAI DAN TERSEDIA DALAM WAKTU SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN

1. PIHAK KEDUA menetapkan waktu yang diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan.
2. Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan yang urgen/gawat darurat diukur.
3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan pasien

PASAL 7

ADA PROSEDUR MELAPORKAN HASIL TES DIAGNOSTIK YANG KRITIS

1. Metode kolaboratif digunakan PIHAK KEDUA untuk mengembangkan prosedur pelaporan hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik
2. Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang kritis untuk setiap tes
3. Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan kepada siapa hasil yang kritis dari pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan
4. Prosedur tersebut menetapkan apa yang dicatat di dalam catatan pasien
5. Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring oleh PIHAK KEDUA

PASAL 8

REAGENSIA ESENSIAL DAN BAHAN LAIN YANG DIPERLUKAN SEHARI-HARI SELALU TERSEDIA DAN DIEVALUASI UNTUK MEMASTIKAN AKURASI DAN PRESISI HASIL.

1. PIHAK KEDUA menetapkan reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia
2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, dan ada proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia
3. Semua reagensia disimpan dan didistribusi sesuai pedoman dari produsen atau instruksi penyimpanan dan distribusi yang ada pada kemasan
4. Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan untuk mengevaluasi semua reagensia agar memberikan hasil yang akurat dan presisi
5. Semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap dan akurat

PASAL 9

DITETAPKAN NILAI NORMAL DAN RENTANG NILAI YANG DIGUNAKAN UNTUK INTERPRETASI DAN PELAPORAN HASIL LABORATORIUM

1. PIHAK KEDUA menetapkan nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang dilaksanakan
2. Rentang nilai rujukan ini harus disertakan dalam catatan klinis pada waktu hasil pemeriksaan dilaporkan
3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bukan laboratorium PIHAK KEDUA harus mencantumkan rentang nilai
4. Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala seperlunya

PASAL 10

PENGENDALIAN MUTU DILAKUKAN, DITINDAKLANJUTI DAN DIDOKUMENTASI UNTUK SETIAP PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pelayanan laboratorium
2. Dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten sesuai prosedur
3. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku
4. Apabila ditemukan penyimpangan dilakukan tindakan perbaikan
5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten
6. Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan di PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA memastikan bahwa pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien
7. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya pemantapan mutu internal dan eksternal

PASAL 11

PROGRAM KESELAMATAN (SAFETY) DIRENCANAKAN, DILAKSANAKAN, DAN DIDOKUMENTASIKAN

1. Terdapat program keselamatan/keamanan laboratorium yang mengatur risiko keselamatan yang potensial di laboratorium PIHAK KEDUA dan di area lain yang mendapat pelayanan laboratorium.
2. Program ini adalah bagian dari program keselamatan di PIHAK KEDUA
3. Petugas laboratorium melaporkan kegiatan pelaksanaan program keselamatan kepada pengelola program keselamatan di PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila terjadi insiden keselamatan
4. Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya

5. Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak lanjut risiko keselamatan di laboratorium
6. Staf laboratorium diberikan orientasi untuk prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja
7. Staf laboratorium mendapat pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun peralatan yang baru.

PASAL 12

MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal ***01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030*** dengan tidak mengurangi hak masing – masing pihak untuk mengakhiri, asalkan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan kedua pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 13

PENUTUP

Demikian Pengikatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. AKH. TAUFIQURAHMAN, MMKes

**Dr. IFIT BAGUS APRIANTONO,
M.MRS, CPPD, CIM, CSBP**